



空泡蝶鞍综合征

作者: [John D. Carmichael](#), MD, Keck School of Medicine of the University of Southern California

Reviewed By [Glenn D. Braunstein](#), MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 6月 2025 | 修改的 7月 2025

在空泡蝶鞍综合征中，蝶鞍（脑底可容纳垂体的骨性结构）充满脑脊液，致使部分或完全压迫垂体，并可能使蝶鞍增大。

（另见[垂体概述](#)。）

正常情况下分隔脑脊液和蝶鞍的组织屏障在空泡蝶鞍综合征患者中出现缺陷。因此，脑脊液会对[垂体](#)和蝶鞍壁造成更大的压力。蝶鞍可能增大，垂体可能萎缩，导致影像学检查显示蝶鞍有空泡。

空泡蝶鞍综合征最常见于超重和患高血压的中年妇女。较少情况下发生在垂体手术、放疗、或垂体肿瘤梗死（坏死）后。

空泡蝶鞍综合征可以完全没有症状，也极少出现严重的症状。大约半数患者有头痛，一些患者有高血压。少数患者有的脑脊液鼻漏或视力障碍。

空蝶鞍综合征可通过[计算机断层扫描](#) (CT) 或[磁共振成像](#) (MRI) 进行诊断。可通过检测血液中的激素水平来检查垂体功能，以排除激素过量或不足。但垂体功能通常是正常的。

很少需要治疗。只有当垂体生成的激素过多或过少时（取决于哪些激素受到影响），才给予治疗。治疗方法可以是补充缺乏的激素或给予减少激素过量生成的药物。